経営分析レポート

東邦大学医療センター大橋病院

2025年度2月実績（2026年3月戦略会議資料）

作成日: 2026年3月28日

大橋病院 2025年度2月実績 経営分析レポート

作成日: 令和8年3月30日
対象期間: 2025年度2月（単月）および4～3月（年度合計）
分析対象: 大橋病院（資料1～資料10、資料1-2、資料1-3）

---

1. エグゼクティブサマリー

総合評価

大橋病院の2025年度2月実績は、入院部門が堅調に推移する一方、外来部門の低迷が継続し、総額で予算未達の状態が続いている。2月単月の診療費総額は12億8,753万円（予算対比98.2%）、累計では148億1,865万円（予算対比97.9%）と、累計で約3.2億円の予算未達である（資料1-1）。

3病院比較において、大橋病院は粗利益予算対比が3病院中最低であり、人件費の増加が収益改善を相殺している構造的課題がある（資料1）。一方、入院単価は3病院中最高水準を維持し、平均在院日数の短縮やDPC期間II以内退院率の改善など、効率性指標では着実な進展が見られる（資料10）。

手術部門については3月データが追加され年度が完結し、年度合計6,336件（前年6,162件、+174件、+2.8%）と前年を上回った（資料3）。全身麻酔は年度合計3,261件で、急性期充実体制加算の施設基準（2,000件/年以上）を大幅に超過している。

前年度対比から見た成長の実態

予算対比では未達が続く一方、前年度対比では大橋病院は着実な成長軌道にあることが確認できる（資料1）。4～2月累計で収入合計は前年比+551,485千円（+3.6%）と約5.5億円の増収を達成し、粗利益は55,297千円→122,991千円と+122.4%（約2.2倍）に改善した。入院単価は累計+4.0%、外来単価は累計+6.0%と診療単価の引き上げに成功しており、手術件数も+2.8%増加している。3病院の前年度対比では、大橋病院の粗利益改善率が最も高く、大森（△32.9%）・佐倉（△26.4%）が前年から減益する中で唯一大幅な増益を実現した。

ただし、この好調な前年度対比と予算未達の乖離は、予算設定の妥当性の検証が必要であることを示唆している。実績ベースの改善を正当に評価しつつ、来年度予算策定においては実態に即した目標設定を検討すべきである。人件費の前年比+7.6%（2月単月）の増加は、収入成長率+3.0%を上回っており、成長の持続性にとってリスク要因である点には留意が必要である。

主要KPIダッシュボード（2月単月）

KPI	実績	予算/目標	予算対比	前年実績	前年比	出典
診療費総額	12億8,753万円	13億1,109万円	▲2,356万円（98.2%）	—	—	資料1-1
医療収入	1,365,064千円	—	—	1,324,859千円	+40,205千円（+3.0%）	資料1
入院診療費	8億2,031万円	8億2,340万円	▲309万円（99.6%）	—	—	資料1-1
入院収入	893,376千円	—	—	891,113千円	+2,263千円（+0.3%）	資料1

外来診療費	4億6,722万円	4億8,769万円	▲2,047万円（95.8%）	—	—	資料1-1
外来収入	466,423千円	—	—	428,171千円	+38,252千円（+8.9%）	資料1
病床稼働率	94.0%	92.0%	○達成	93.2%	+0.7pt	資料1-1
平均在院日数	9.1日	9.0日	ほぼ達成	9.5日	△0.4日（△4.2%）	資料1-1
入院単価	97,424円	98,511円	▲1,087円	98,105円	△681円	資料1-1
外来単価	24,001円	22,647円	○+1,354円	22,206円	+1,795円（+8.1%）	資料1-1
1日平均外来患者数	846.4人	944.4人	[!]▲98.0人	929.6人	△83.2人（△9.0%）	資料1
粗利益（単月）	154,684千円	199,033千円	[!]▲44,349千円	164,373千円	△9,689千円（△5.9%）	資料1
粗利益率（単月）	11.1%	14.2%	[!]▲3.1pt	12.2%	△1.1pt	資料1
手術件数（年度合計）	6,336件	—	+174件（前年比+2.8%）	6,162件	+174件（+2.8%）	資料3
紹介率	87.1%	65%以上	○達成	83.8%	+3.3pt	資料7
後発医薬品指数	96.1%	90%以上	○達成	—	—	資料6

主要KPIダッシュボード（4～2月累計）

KPI	累計実績	前年累計	前年比	出典
医療収入	15,527,317千円	15,062,283千円	+465,034千円（+3.1%）	資料1
入院収入	10,327,437千円	9,995,882千円	+331,555千円（+3.3%）	資料1
外来収入	5,125,839千円	5,006,726千円	+119,113千円（+2.4%）	資料1
収入合計	15,841,950千円	15,290,465千円	+551,485千円（+3.6%）	資料1
支出合計	15,718,959千円	15,235,168千円	+483,791千円（+3.2%）	資料1
粗利益	122,991千円	55,297千円	+67,694千円（+122.4%）	資料1
粗利益率	0.8%	0.4%	+0.4pt	資料1
人件費	6,519,108千円	6,496,788千円	+22,320千円（+0.3%）	資料1
入院単価（累計）	101,517円	97,592円	+3,925円（+4.0%）	資料1-1

外来単価（累計）	22,841円	21,551円	+1,290円（+6.0%）	資料1-1
1日平均入院患者数（累計）	284.4人	286.5人	△2.1人（△0.7%）	資料1-1
病床稼働率（累計）	88.9%	89.7%	△0.8pt	資料1-1
新入院患者数（累計）	9,595人	9,359人	+236人（+2.5%）	資料1-1

---

2. 収支分析

2.1 総額

予算対比

項目	2月実績	予算	予算差	予算対比	出典
診療費総額	1,287,527千円	1,311,089千円	▲23,562千円	98.2%	資料1-1
累計総額	14,818,646千円	15,141,036千円	▲322,390千円	97.9%	資料1-1

前年度対比

項目	2月実績	前年同月	前年差	前年比	出典
医療収入（2月単月）	1,365,064千円	1,324,859千円	+40,205千円	+3.0%	資料1
医療収入（4～2月累計）	15,527,317千円	15,062,283千円	+465,034千円	+3.1%	資料1
収入合計（2月単月）	1,390,092千円	1,347,543千円	+42,549千円	+3.2%	資料1
収入合計（4～2月累計）	15,841,950千円	15,290,465千円	+551,485千円	+3.6%	資料1

【事実】
予算対比では2月単月98.2%で前月（97.8%）よりやや改善したが、累計97.9%と約3.2億円の未達が続いている。4月を除く全月で予算未達である。一方、前年度対比では、2月単月で医療収入+3.0%、収入合計+3.2%の増収を達成。累計でも医療収入+3.1%（+4億6,503万円）、収入合計+3.6%（+5億5,149万円）と着実な成長を示している（資料1）。

【解釈】
年度末の3月で累計予算達成は極めて困難であるが、前年度対比では3%超の増収を実現しており、病院としての収益力は向上している。予算未達の要因は、予算設定が成長率以上の水準に設定されていた可能性がある。来年度予算策定にあたっては、実績ベースの成長トレンドを踏まえた現実的な目標設定が重要である。

2.2 入院収入

予算対比

項目	2月実績	予算	予算差	予算対比	出典

入院診療費	820,307千円	823,398千円	▲3,091千円	99.6%	資料1-1
累計	9,644,523千円	9,673,981千円	▲29,458千円	99.7%	資料1-1

前年度対比

項目	2月実績	前年同月	前年差	前年比	出典
入院収入（2月単月）	893,376千円	891,113千円	+2,263千円	+0.3%	資料1
入院収入（4～2月累計）	10,327,437千円	9,995,882千円	+331,555千円	+3.3%	資料1
入院単価（累計）	101,517円	97,592円	+3,925円	+4.0%	資料1-1

【事実】
入院は2月単月で予算比99.6%とほぼ達成。累計でも99.7%とほぼ予算並みで推移。病床稼働率94.0%が寄与している。前年度対比では、2月単月+0.3%と微増であるが、累計では+3.3%（+3億3,156万円）の増収を達成している。特に入院単価は累計で97,592円→101,517円（+4.0%）と大幅に上昇しており、ケースミックスの改善が入院収入を牽引している（資料1、資料1-1）。

【解釈】
入院部門は予算・前年いずれとの比較でも堅調である。入院単価の前年比+4.0%の上昇は、高度急性期医療への集約と効率的な病床運用の成果である。

2.3 外来収入

予算対比

項目	2月実績	予算	予算差	予算対比	出典
外来診療費	467,220千円	487,691千円	▲20,471千円	95.8%	資料1-1
累計	5,174,123千円	5,467,055千円	▲292,932千円	94.6%	資料1-1

前年度対比

項目	2月実績	前年同月	前年差	前年比	出典
外来収入（2月単月）	466,423千円	428,171千円	+38,252千円	+8.9%	資料1
外来収入（4～2月累計）	5,125,839千円	5,006,726千円	+119,113千円	+2.4%	資料1
外来単価（2月単月）	24,001円	22,206円	+1,795円	+8.1%	資料1-1
外来単価（累計）	22,841円	21,551円	+1,290円	+6.0%	資料1-1
1日平均外来患者数	846.4人	929.6人	△83.2人	△9.0%	資料1

【事実】
外来は予算対比では累計94.6%で約2.9億円の未達であり、全体未達の主因である。1日平均外来患者数は846.4人で予算944.4人を大幅に下回る（資料1）。外来単価は24,001円と予算22,647円を上回っているが、患者数減を補えていない。一方、前年度対比では、2月単月の外来収入は+8.9%（+38,252千円）と大幅増収。累計でも+2.4%（+1億1,911万円）の増収を確保している。患者数は前年比△9.0%減少しているにもかかわらず、外来単価が+8.1%（2月単月）、+6.0%（累計）と大幅に上昇したことで、収入増を実現している（資料1、資料1-1）。

【解釈】
外来部門は「患者数減少・単価上昇」の二面的な構造を持つ。予算未達は患者数減が主因であるが、前年度対比では単価向上が患者数減を上回り増収を達成している。患者数の回復が実現すれば、単価上昇との相乗効果で大幅な増収が見込めるため、外来患者数の回復施策は引き続き最優先課題である。

2.4 収支バランス（資料1より）

実績総括

項目	2月単月	4～2月累計	出典
収入合計	1,390,092千円	15,841,950千円	資料1
支出合計	1,235,408千円	15,718,959千円	資料1
粗利益	154,684千円	122,991千円	資料1
粗利益率	11.1%	0.8%	資料1
基本金組入前収支差額	18,323千円	▲1,376,980千円	資料1

前年度対比（収支バランス）

項目	当年度	前年度	前年差	前年比	出典
収入合計（2月単月）	1,390,092千円	1,347,543千円	+42,549千円	+3.2%	資料1
支出合計（2月単月）	1,235,408千円	1,183,170千円	+52,238千円	+4.4%	資料1
粗利益（2月単月）	154,684千円	164,373千円	△9,689千円	△5.9%	資料1
粗利益率（2月単月）	11.1%	12.2%	△1.1pt	—	資料1
収入合計（累計）	15,841,950千円	15,290,465千円	+551,485千円	+3.6%	資料1
支出合計（累計）	15,718,959千円	15,235,168千円	+483,791千円	+3.2%	資料1
粗利益（累計）	122,991千円	55,297千円	+67,694千円	+122.4%	資料1
粗利益率（累計）	0.8%	0.4%	+0.4pt	—	資料1
人件費（2月単月）	440,637千円	409,471千円	+31,166千円	+7.6%	資料1
人件費（累計）	6,519,108千円	6,496,788千円	+22,320千円	+0.3%	資料1
医療経費（2月単月）	541,940千円	531,528千円	+10,412千円	+2.0%	資料1
医療経費（累計）	6,313,137千円	5,958,888千円	+354,249千円	+5.9%	資料1

【事実】
2月単月の粗利益は予算199,033千円に対し154,684千円（▲44,349千円）で未達。前年同月比でも164,373千円→154,684千円（△5.9%）と悪化した。2月単月では収入の伸び（+3.2%）を支出の伸び（+4.4%）が上回り、特に人件費+7.6%の増加が粗利益を圧迫した（資料1）。

一方、累計ベースでは構造が大きく異なる。収入合計は前年比+3.6%の成長に対し、支出合計の増加は+3.2%にとどまり、収入成長率が支出増加率を上回ったことで、粗利益は55,297千円→122,991千円（+122.4%、+67,694千円）と2倍以上に改善した。累計の人件費増加率は+0.3%と抑制されており、2月単月の+7.6%は一時的な変動要因を含んでいる可能性がある（資料1）。

【解釈】
2月単月の粗利益悪化（前年比△5.9%）と累計の粗利益大幅改善（前年比+122.4%）は一見矛盾するが、累計ベースで収入成長率（+3.6%）が支出増加率（+3.2%）を上回る構造が年度を通じて構築されたことの表れである。2月単月の人件費急増は一時要因か構造要因か、3月以降のモニタリングが必要である。

---

3. 3病院比較分析（深掘り）

3.1 主要指標一覧比較（2月単月）

指標	大森	大橋	佐倉	大橋の位置	出典
医療収入	3,337,495千円	1,365,064千円	1,516,198千円	3位[!]	資料1
収入前年比	+11.0%	+3.0%	▲0.4%	2位	資料1
粗利益	545,427千円	154,684千円	134,703千円	2位	資料1
粗利益率	16.2%	11.1%	8.8%	2位	資料1
粗利益予算対比	+48,648千円	▲44,349千円	▲23,025千円	3位[!]	資料1
人件費増加率（前年比）	+0.7%	+7.6%	▲0.7%	3位[!]	資料1
入院1日平均患者数	738.8人	300.7人	345.4人	3位	資料1
入院単価	99,863円	98,187円	83,341円	2位	資料1
病床稼働率	92.2%	94.0%	90.9%	1位	資料1
平均在院日数	10.6日	9.1日	9.8日	1位（最短）	資料1
手術件数	1,119件	497件	493件	2位	資料1
外来1日平均患者数	1,895.7人	846.4人	1,045.0人	3位[!]	資料1
外来単価	26,162円	23,960円	28,938円	3位[!]	資料1
外来新患者数（1日平均）	142.0人	61.5人	60.3人	2位	資料1

3.2 年度合計（4～3月）比較

指標	大森	大橋	佐倉	大橋の位置	出典
医療収入	36,363,695千円	15,527,317千円	17,845,655千円	3位[!]	資料1
収入予算対比	▲0.0%	▲1.9%	▲2.2%	2位	資料1
粗利益率	2.1%	0.8%	0.5%	2位	資料1
基本金組入前収支差額	▲1,237,318千円	▲1,376,980千円	▲893,244千円	3位[!]	資料1
入院単価（累計）	94,747円	100,719円	85,521円	1位	資料1
病床稼働率（累計）	88.1%	88.9%	90.3%	2位	資料1
手術件数（年度合計）	—	6,336件	—	—	資料3
外来患者数（1日平均累計）	1,940.1人	851.6人	1,027.5人	3位[!]	資料1
外来単価（累計）	24,419円	22,628円	28,090円	3位[!]	資料1

※
手術件数は3月データ追加により年度が完結。大橋病院の年度合計は6,336件（前年6,162件、+174件、+2.8%）（資料3）。大森・佐倉の3月データは未入手のため4～2月累計値（11,931件、5,704件）を参考値として記載省略。

3.3 大橋病院が劣位にある指標の分析

[!] 医療収入（3位）

・事実: 2月単月1,365,064千円で佐倉（1,516,198千円）を約1.5億円下回る（資料1）
・原因: 外来患者数の大幅な不足が主因。入院収入は佐倉を上回っている
・改善策: 外来患者数の回復施策（後述）が最優先

[!] 粗利益予算対比（3位）

・事実: 予算比▲44,349千円で3病院中最大の未達（資料1）
・原因:
収入面の予算未達（▲15,045千円）に加え、支出が予算比+29,304千円（+2.4%）。特に人件費が予算比+34,252千円（+8.4%）と突出
・改善策: 人件費管理の厳格化。特に超過勤務・人員配置の適正化を検討すべき

[!] 人件費増加率（3位、前年比+7.6%）

・事実: 大森+0.7%、佐倉▲0.7%に対し、大橋のみ+7.6%と突出（資料1）
・原因: 累計でも+105,674千円（予算比+1.6%）の超過。人件費率の上昇が粗利益を圧迫
・改善策: 診療科別の人件費分析を行い、増加要因を特定。業務効率化・シフト最適化の推進

[!] 外来1日平均患者数（3位）

・事実: 846.4人で予算944.4人を▲98.0人下回る。前年同月929.6人からも▲83.2人（▲9.0%）の減少（資料1）
・原因: 初診患者数が61.5人/日で前年68.6人/日から▲10.3%減少。紹介患者数も累計で前年比▲284件（資料1-1、資料7）
・改善策:
紹介元医療機関への営業強化、特に減少が著しい整形外科（累計▲543件）・耳鼻科（累計▲182件）・消化器内科（累計▲283件）への対応（資料7-2）

[!] 外来単価（3位）

・事実: 23,960円で佐倉28,938円と約5,000円の差（資料1）
・原因: 外来化学療法や高度検査の構成比の差と推測される
・改善策: 外来化学療法のさらなる推進（2月252件、前年比+43件と改善傾向、資料2）、高度医療の外来シフト

[!] 基本金組入前収支差額（累計、3位）

・事実: ▲13億7,698万円で3病院中最大の赤字（資料1）
・原因: 収入の予算未達と人件費増加の複合要因。減価償却額も年間約12.4億円と大きい
・改善策: 上記のすべての改善策を複合的に実行する必要がある

3.4 各病院の強み・弱みマトリックス

病院	強み	弱み
大森	収入規模・成長率ともにトップ（前年比+10.5%）、手術件数圧倒的（1,119件/月）、粗利益率最高（16.2%）	外来患者数が予算比▲10.2%と大幅減、医療経費の急増（前年比+19.0%）
大橋	入院単価3病院最高（累計100,719円）、平均在院日数最短（9.1日）、病床稼働率最高（94.0%）、DPC期間II以内退院率目標達成（71.6%）	外来患者数が最も少なく減少幅も最大、人件費増加率突出、粗利益予算対比最悪
佐倉	外来単価最高（28,938円）、人件費抑制に成功（前年比▲0.7%）、支出コントロール良好	入院単価最低（83,341円）、入院患者数減少（前年比▲3.6%）、手術件数減少傾向

3.5 ベンチマーク（大橋が目指すべき水準）

指標	現状（大橋）	目指すべき水準	根拠

外来1日平均患者数	846.4人	900人以上	予算水準（944人）は困難だが、前年929人の97%程度を短期目標に
粗利益率（単月）	11.1%	14%以上	予算想定の14.2%を基準に
人件費増加率	+7.6%	+2%以内	大森（+0.7%）と佐倉（▲0.7%）の平均を参考に
外来単価	23,960円	25,000円以上	大森26,162円に近づけることを中期目標に
紹介件数（月間）	1,105件	1,250件以上	前年度月平均1,252件の水準回復

3.6 前年度対比による3病院成長率比較（4～2月累計）

前年度対比で3病院の成長実態を比較すると、予算対比とは大きく異なる評価が浮かび上がる（資料1）。

収入・利益の前年度対比

指標	大森	大橋	佐倉	大橋の位置	出典
収入合計 前年比	+4.4%	+3.6%	+1.6%	2位	資料1
粗利益 前年比	△32.9%	+122.4%	△26.4%	1位	資料1
粗利益額（前年）	1,133,231千円	55,297千円	122,536千円	—	資料1
粗利益額（当年）	760,402千円	122,991千円	90,213千円	—	資料1
粗利益増減額	△372,829千円	+67,694千円	△32,323千円	1位	資料1
人件費 前年比	+1.4%	+0.3%	+0.6%	1位（最小）	資料1

【事実】
前年度対比では、大橋病院は3病院中唯一の増益を達成している。大森は収入+4.4%の成長にもかかわらず粗利益が△32.9%（△3億7,283万円）と大幅減益、佐倉も粗利益△26.4%（△3,232万円）と減益しているのに対し、大橋は粗利益+122.4%（+6,769万円）と倍増以上の改善である。また、累計の人件費増加率は大橋が+0.3%で3病院中最も抑制されている（資料1）。

【解釈】
予算対比では大橋が3病院中最低の評価を受けているが、前年度対比では大橋が3病院中最も健全な経営改善を実現している。大森は収入の大幅成長にもかかわらず医療経費の急増により減益に転じ、佐倉も収入の伸び悩みにより減益している。大橋は収入の着実な成長（+3.6%）と支出の管理（累計人件費+0.3%）により、収支構造の改善に成功した。この事実は、予算対比のみで経営状況を評価することの限界を示しており、前年度対比を含む多面的な評価の必要性を強く示唆している。

ただし、粗利益の絶対額（122,991千円、粗利益率0.8%）は依然として薄く、収支の安定性という観点では改善の余地が大きい。前年度対比の大幅改善は、前年の粗利益水準が極めて低かった（55,297千円、0.4%）ことの裏返しでもあり、改善率の高さのみをもって楽観視すべきではない。

---

4. 資料1-2：診療科別前年比較（2025年2月 vs 前年度月平均）

4.1 外来・入院合算による診療科別総合評価

外来と入院を合算した診療科別の前年差額を算出し、収益インパクトの大きい順にランキングした（資料1-2）。

成長科ランキング（合算差額プラス上位10科）

順位	診療科	外来差(点)	入院差(点)	合計差(点)	合計差(万円)	主な成長要因
1	外科	+680,852	+2,448,769	+3,129,621	+3,130万円	化学療法急増、手術件数・単価とも増
2	泌尿器科	+495,359	+191,615	+686,974	+687万円	化学療法急増、ダヴィンチ手術の単価効果
3	消化器内科	+178,653	+427,405	+606,058	+606万円	化学療法・内視鏡治療の増加
4	放射線科	+397,014	+68,703	+465,717	+466万円	放射線治療（IMRT）の回復
5	産婦人科	+139,373	+249,072	+388,445	+388万円	手術件数増（前年比+24.6%）、入院単価+55.3%
6	形成外科	+8,550	+107,443	+115,993	+116万円	入院手術関連が増
7	循環器内科	+471,054	△355,901	+115,153	+115万円	外来注射増だが入院カテーテル関連減
8	耳鼻咽喉科	△156,122	+197,353	+41,231	+41万円	外来患者減だが入院手術増
9	脳神経内科	+306,519	△271,857	+34,662	+35万円	外来注射増だが入院は減少
10	乳癌センター	+18,725	—	+18,725	+19万円	外来化学療法

縮小科ランキング（合算差額マイナス上位9科）

順位	診療科	外来差(点)	入院差(点)	合計差(点)	合計差(万円)	主な縮小要因
1	整形外科	△262,878	△2,229,377	△2,492,255	△2,492万円	患者数激減（外来△290、入院△221）、手術・手術材料の全面減
2	脳神経外科	△68,554	△1,548,229	△1,616,783	△1,617万円	入院手術・手術材料が激減
3	心臓血管外科	△101,436	△1,461,230	△1,562,666	△1,563万円	手術件数減による全面的な収益減
4	眼科	△372,519	△187,487	△560,006	△560万円	外来患者数△234、注射（硝子体注射等）△276,100
5	リウマチ膠原病痛風	△257,537	△249,401	△506,938	△507万円	生物学的製剤の自己注射化、入院患者△55
6	呼吸器内科	△182,630	△75,129	△257,759	△258万円	外来検査・画像△243,601、患者数△182
7	腎臓内科	△128,100	△106,434	△234,534	△235万円	外来処置（透析関連）△105,903、入院処置△168,145
8	皮膚科	△70	△161,283	△161,353	△161万円	入院患者△40、入院DPC△113,927
9	小児科	△95,626	+27,587	△68,039	△68万円	外来在宅料△39,422、検査△56,134

【事実】
成長科の合計差は約+5,608万円、縮小科の合計差は約△7,461万円であり、縮小科の減収インパクトが成長科の増収を上回っている。外来全体では+952,460点（+2.1%）のプラスだが、入院全体では△3,089,447点（△3.6%）のマイナスであり、病院全体では△2,136,987点（約△2,137万円）の減収となっている（資料1-2）。

【解釈】
外科が+3,130万円と突出した成長を見せる一方、整形外科が△2,492万円と最大の減収科であり、この2科の明暗が病院全体の収益構造を大きく左右している。縮小科上位3科（整形外科・脳神経外科・心臓血管外科）はいずれも手術・手術材料の大幅減少が主因であり、手術症例の確保が喫緊の課題である。

4.2 成長科（5科）の詳細分析

外科（合算+3,129,621点、+3,130万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	5,452,178	4,771,326	+680,852	+14.3%
入院	14,441,376	11,992,607	+2,448,769	+20.4%

【事実】
外来・入院とも二桁成長を達成。外来は患者数+78人（+5.6%）、単価+282点（+8.3%）と量・質ともに伸長。入院は患者数+165人（+14.2%）、単価+562点（+5.4%）と特に患者数の増加が顕著。入院の主な増加項目は手術+860,131点、入院料+587,514点、DPC+410,700点（資料1-2）。

【解釈】
外来注射+649,520点（化学療法）と入院手術+860,131点の同時増加は、がん診療体制の強化が結実していることを示す。化学療法で集患し、手術適応症例を確保する好循環が形成されている。外来化学療法の累計件数も外科が全科最多（1,481件、資料2）であり、がん拠点病院としての機能強化が収益に直結している。

泌尿器科（合算+686,974点、+687万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	3,010,530	2,515,171	+495,359	+19.7%
入院	2,770,797	2,579,182	+191,615	+7.4%

【事実】
外来は患者数△156人（△11.1%）の減少にもかかわらず、単価+616点（+34.5%）の大幅上昇により+19.7%の増収を達成。外来注射+672,812点（化学療法、前年比+107%の急増）が牽引。入院は患者数△44人（△14.5%）の減少だが、単価+2,173点（+25.6%）の上昇で+7.4%の増収。手術薬剤+249,269点が入院の主な増加項目（資料1-2）。

【解釈】
外来注射+672,812点（前年比+107%）の急増は、免疫チェックポイント阻害薬（ニボルマブ、ペムブロリズマブ等）をはじめとする新規化学療法レジメンの導入が主因と推察される。入院の手術薬剤+249,269点は、ダヴィンチ手術における高額薬剤の使用増と考えられ、ロボット支援手術の単価効果が収益に貢献している。患者数は外来・入院とも減少しているため、現在の増収は単価上昇に依存しており、患者数の維持・確保が今後の持続性を左右する。

消化器内科（合算+606,058点、+606万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率

外来	4,184,048	4,005,395	+178,653	+4.5%
入院	7,876,551	7,449,146	+427,405	+5.7%

【事実】
外来は患者数△29人（△1.7%）の微減だが、単価+149点（+6.3%）の上昇で+4.5%の増収。外来注射+138,111点、手術薬剤+98,384点が増加。入院は患者数+15人（+1.4%）の微増に加え、単価+296点（+4.3%）の上昇で+5.7%の増収。入院の手術+158,998点、手術材料+98,603点、画像+104,656点が主な増加項目（資料1-2）。

【解釈】
入院の手術+158,998点・手術材料+98,603点の増加は、内視鏡的粘膜切除術（EMR）や内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）等の高度内視鏡治療の拡大を示唆する。外来化学療法と入院内視鏡治療の両輪で安定的に成長しており、消化器内科は外来・入院のバランスが最も取れた成長科といえる。

放射線科（合算+465,717点、+466万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	1,603,826	1,206,812	+397,014	+32.9%
入院	412,109	343,406	+68,703	+20.0%

【事実】
外来が+32.9%の大幅増収。放射線治療+363,278点、画像+48,994点が主な増加項目。患者数は+123人（+29.0%）と大幅に増加し、単価も+86点（+3.0%）上昇（資料1-2）。

【解釈】
放射線治療（IMRT）の回復が収益増に直結している。2月のIMRT236件は今年度最高で前年同月77件の3倍超（資料9）であり、放射線治療の症例確保が奏功している。外来患者数+123人の増加は、他の多くの科が患者数減少に苦しむ中で際立つ成長であり、放射線治療の需要増を反映している。

産婦人科（合算+388,445点、+388万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	1,021,836	882,463	+139,373	+15.8%
入院	2,030,117	1,781,045	+249,072	+14.0%

【事実】
外来は患者数+12人（+2.2%）の微増と単価+212点（+13.4%）の上昇で+15.8%の増収。外来注射+126,747点が主な増加項目。入院は患者数△45人（△26.6%）の大幅減少にもかかわらず、単価+5,833点（+55.3%）の劇的な上昇で+14.0%の増収。入院の手術+337,348点が最大の増加項目（資料1-2）。

【解釈】
手術件数の大幅増（年度合計+63件、+24.6%、資料3）が入院単価+55.3%の上昇に直結している。入院患者数の減少（△45人）にもかかわらず増収を達成していることから、1件あたりの手術侵襲度（＝診療報酬額）が大幅に上昇していると考えられる。診療体制の充実により、より高度な手術症例を受け入れられるようになった可能性がある。

4.3 縮小科（5科）の詳細分析

整形外科（合算△2,492,255点、△2,492万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	1,895,838	2,158,716	△262,878	△12.2%
入院	5,663,443	7,892,820	△2,229,377	△28.2%

【事実】
外来・入院ともに全面的な減少。外来は患者数△290人（△13.3%）、入院は患者数△221人（△24.9%）と大幅に減少。入院ではDPC△608,902点、手術材料△618,194点、手術△446,345点、入院料△220,606点、検査△201,311点と、すべての主要項目が減少している（資料1-2）。

【解釈】
紹介件数の激減（累計△543件、資料7-2）が患者数減少に直結している。整形外科は紹介患者への依存度が高く、紹介元の減少がそのまま手術件数・入院患者数の減少を招いている。さらに、ベッド満床による紹介拒否（2月3件、資料7-1）が発生しており、「紹介減→患者減→ベッド空き→他科利用→整形ベッド不足→紹介拒否→さらなる紹介減」という悪循環に陥っている可能性がある。合算△2,492万円は病院全体の最大の減収要因であり、最優先で対策を講じるべき診療科である。

脳神経外科（合算△1,616,783点、△1,617万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	1,215,793	1,284,347	△68,554	△5.3%
入院	5,064,393	6,612,622	△1,548,229	△23.4%

【事実】
入院が△23.4%の大幅減収。手術△536,994点、手術材料△423,449点、DPC△186,453点、入院料△226,512点と手術関連の落ち込みが深刻。入院患者数は+43人（+5.9%）と増加しているにもかかわらず、単価が△2,527点（△27.7%）と大幅に低下している（資料1-2）。

【解釈】
入院患者数は増えているのに単価が△27.7%と激減していることから、高額手術（脳腫瘍摘出術、脳動脈瘤クリッピング術等）の症例が減少し、相対的に低単価の保存的治療入院が増加していると推察される。手術△536,994点・手術材料△423,449点の減少は、1件あたりの手術材料使用量が大きい開頭手術の症例減を示唆しており、手術件数自体は横ばい（年度合計154件 vs 前年153件、+1件、資料3）であることから、手術の構成（ケースミックス）が低侵襲化・低単価化にシフトしたと考えられる。

心臓血管外科（合算△1,562,666点、△1,563万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	341,238	442,674	△101,436	△22.9%
入院	6,024,134	7,485,364	△1,461,230	△19.5%

【事実】
外来・入院とも大幅減。入院は手術△520,200点、手術材料△406,085点、処置△171,196点、DPC△154,539点、入院料△115,317点とすべての主要項目が減少。患者数は外来△66人（△17.5%）、入院△72人（△22.8%）と大幅減少（資料1-2）。

【解釈】
手術全般の減少（手術△520,200点、手術材料△406,085点）は、開心術（冠動脈バイパス術、弁置換術等）の症例減を示唆する。循環器領域全体で経カテーテル治療（TAVI等）へのシフトが進んでおり、従来の開心術症例が減少している可能性がある。年度合計の手術件数も258件（前年271件、△13件、△4.8%、資料3）と減少しており、手術症例の確保が構造的な課題となっている。循環器内科の入院カテーテル関連材料△1,010,260点の減少と併せると、循環器領域全体での治療方針の変化が読み取れる。

眼科（合算△560,006点、△560万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	2,834,472	3,206,991	△372,519	△11.6%
入院	3,875,523	4,063,010	△187,487	△4.6%

【事実】
外来が△11.6%の減収で、注射△276,100点が最大の減少要因。外来患者数は△234人（△11.7%）、入院患者数は△93人（△22.6%）と大幅減少。一方、入院単価は+2,302点（+23.3%）と大幅上昇しており、入院の減収幅を一定程度抑制している（資料1-2）。

【解釈】
外来注射△276,100点の減少は、抗VEGF薬（アイリーア、ルセンティス等）の硝子体内注射件数の減少が主因と推察される。加齢黄斑変性や糖尿病黄斑浮腫に対する硝子体注射は高単価の処置であり、件数減少が大きな収益減に直結する。患者数の大幅減少は、競合他院（特に眼科専門クリニック）への患者流出の可能性がある。手術件数は年度合計2,502件（前年2,468件、+34件、資料3）と微増しており、手術は堅調だが、外来注射の減少がそれを上回る減収要因となっている。

リウマチ膠原病痛風（合算△506,938点、△507万円）

部門	2月合計(点)	前年月平均(点)	差分(点)	増減率
外来	5,617,398	5,874,935	△257,537	△4.4%
入院	1,077,508	1,326,909	△249,401	△18.8%

【事実】
外来は患者数△66人（△7.0%）、入院は患者数△55人（△21.4%）と患者数の減少が続く。外来単価は+172点（+2.8%）と微増しているが、患者数減を補えていない（資料1-2）。

【解釈】
生物学的製剤の自己注射化（在宅自己注射指導管理料への移行）が進むことで、来院頻度の減少と外来注射収入の減少が生じていると考えられる。リウマチ領域では治療の成熟化（寛解維持療法への移行）に伴い、通院間隔の延長が標準化しており、構造的な患者数減少が続く可能性がある。

4.4 外来の構造変化

全体像

指標	2月実績	前年月平均	差分	増減率
外来合計	46,721,971点	45,769,510点	+952,460点	+2.1%
患者数合計	19,467人	21,277人	△1,810人	△8.5%
平均単価	2,401点	2,151点	+250点	+11.6%

【事実】
外来は患者数が△8.5%（△1,810人）と全科的に減少しているにもかかわらず、単価が+11.6%（+250点）と大幅に上昇したことで、総額では+2.1%（+952,460点、約+952万円）のプラスを確保している（資料1-2）。

【解釈】
外来の「患者数減・単価増」構造は、注射（化学療法）の大幅増が牽引している。外来全体の注射増加額は上位5科だけで+2,291,603点に達する。

注射（化学療法）の影響 — 外来単価上昇の原動力

順位	診療科	外来注射増加(点)	特記事項
1	泌尿器科	+672,812	前年比+107%の急増、免疫チェックポイント阻害薬等
2	外科	+649,520	化学療法件数増（累計1,481件、全科最多）
3	循環器内科	+522,655	—
4	脳神経内科	+352,217	—
5	消化器内科	+138,111	—

【事実】
化学療法関連の注射が外来増収の最大の牽引力となっている。泌尿器科の+672,812点（前年比+107%）は、同科の外来増収+495,359点を上回る寄与度であり、注射増がなければ同科は外来減収であった計算になる（資料1-2）。

4.5 入院の構造変化

全体像

指標	2月実績	前年月平均	差分	増減率
入院合計	82,030,706点	85,120,153点	△3,089,447点	△3.6%
患者数合計	8,420人	8,704人	△284人	△3.3%
平均単価	9,742点	9,779点	△37点	△0.4%

【事実】
入院は患者数△3.3%（△284人）の減少に加え、単価も△0.4%（△37点）と微減し、総額で△3.6%（△3,089,447点、約△3,089万円）の減収となっている（資料1-2）。

手術関連項目の構造的変化 — 入院減収の主因

項目	差分(点)	評価	主な内訳
手術	+74,551	微増	外科+860,131 vs 脳外△536,994、心外△520,200、整形△446,345
手術材料	△2,190,885	最大の減収要因	循内△1,010,260、整形△618,194、脳外△423,449、心外△406,085
手術薬剤	+374,353	増加	泌尿器+249,269、循内+297,138
麻酔	△100,013	減少	—

【事実】
手術材料△2,190,885点が入院減収の最大の単一要因である。循環器内科（△1,010,260点）、整形外科（△618,194点）、脳神経外科（△423,449点）、心臓血管外科（△406,085点）の4科で手術材料減少の大部分を占める。手術件数自体は微増（+74,551点）であることから、高額材料を使用する手術（カテーテル、人工関節、脳血管デバイス、人工弁等）の症例減が構造的な減収要因となっている（資料1-2）。

【解釈】
手術材料の減少は、技術料（手術）の減少を大きく上回っており、材料集約型の高額手術（PCI、人工関節置換術、開頭術、開心術）の症例数減少が病院全体の収益を圧迫している。これらの手術は1件あたりの収益貢献が極めて大きいため、少数の症例減が大きな金額インパクトを生む構造に

ある。

4.6 診療科ポートフォリオの推察 — 増減要因と今後の見通し

各科の増減データから推察される構造的な要因と今後の見通しを以下に整理する。

成長が持続する見込みの科

外科:
化学療法（外来注射+649,520点）と手術件数増（入院手術+860,131点）が同時に実現しており、がん診療体制の強化が結実している。外来化学療法で集患→手術適応症例の確保→入院収入増という好循環が形成されており、がん拠点病院としての機能が強化されている限り、成長の持続性は高い。

泌尿器科:
化学療法急増（外来注射+672,812点、前年比+107%）は、免疫チェックポイント阻害薬等の新規レジメン導入によるものと推察される。さらにダヴィンチ手術の単価効果（入院手術薬剤+249,269点）も寄与している。新規薬剤の適応拡大は今後も続く可能性が高く、成長余地がある。ただし患者数は外来△156人・入院△44人と減少しており、単価依存の成長構造にはリスクがある。

消化器内科:
化学療法と内視鏡治療の両輪で成長（入院手術+158,998点、手術材料+98,603点）。内視鏡的粘膜切除術等の高度治療の拡大が入院収入を押し上げている。外来・入院のバランスが良く、持続的な成長が見込まれる。

放射線科:
放射線治療（IMRT）の回復（外来+363,278点）が収益増に直結。ただし月次変動が大きく（金額6,823千円～16,326千円、資料9）、安定的な症例確保が持続性の鍵を握る。

産婦人科:
手術件数の大幅増（年度+24.6%、資料3）が入院単価+55.3%の上昇に直結。手術+337,348点の増加は、より高度な手術（腹腔鏡下手術等）の拡大を示唆する。診療体制の充実が寄与しており、人員体制が維持される限り成長は継続しうる。

構造的な課題を抱える科

整形外科:
全面的な減少（外来△262,878点、入院△2,229,377点）は、紹介件数の激減（累計△543件、資料7-2）が直結している。ベッド満床による紹介拒否（2月3件、資料7-1）が悪循環を生んでおり、病床運用の改善と紹介元への関係修復が急務である。年度合計手術件数も767件（前年774件、△7件、資料3）と減少しており、回復には紹介件数の増加→手術件数の回復という順序で取り組む必要がある。

脳神経外科: 入院手術関連が激減（手術△536,994点、手術材料△423,449点）。手術件数自体は横ばい（154件 vs 153件）であることから、高額手術（脳腫瘍摘出術、脳動脈瘤クリッピング術等）の症例が減少し、低単価の手術にシフトしている。高額症例の確保には専門医の充実と救急受入体制の強化が必要であり、短期的な回復は困難と推察される。

心臓血管外科:
手術全般の減少（手術△520,200点、手術材料△406,085点）は、開心術の症例減を反映している。循環器領域全体で経カテーテル治療（TAVI、MitraClip等）へのシフトが進んでおり、従来型の開心術症例は構造的に減少する傾向にある。循環器内科との協働による経カテーテル治療の拡充が、領域全体の収益確保の方向性となりうる。

眼科:
外来注射△276,100点が主因であり、抗VEGF薬（アイリーア等）の硝子体内注射件数の減少が直接的な減収要因である。競合他院（眼科専門クリニック）への患者流出の可能性があり、手術件数は微増（+34件、資料3）ながらも外来の落ち込みを補えていない。硝子体注射の再集患施策が必要である。

循環器内科:
外来+471,054点だが入院△355,901点で、合算では+115,153点と辛うじてプラスを維持。しかし入院のカテーテル関連材料△1,010,260点は病院全体の手術材料減少の最大要因であり、PCI（経皮的冠動脈インターベンション）件数の減少が推察される。DPC+657,950点の増加は入院患者数

の維持によるものだが、高額手術材料の使用減がそれを上回る減収インパクトを生んでいる。

---

5. 入院部門分析

5.1 患者数・稼働率

指標	2月実績	予算/目標	前年同月	前年比	出典
1日平均入院患者数	300.7人	301.1人	298.4人	+2.3人（+0.8%）	資料1-1
延患者数	8,420人	-	8,355人	+65人	資料1-1
入院患者数（新規）	837人	-	793人	+44人	資料1-1
病床稼働率	94.0%	92.0%	93.2%	+0.7pt	資料1-1
新入院患者数（累計）	9,595人	—	9,359人	+236人（+2.5%）	資料1-1
病床稼働率（累計）	88.9%	—	89.7%	△0.8pt	資料1-1

【事実】
2月の病床稼働率94.0%は今年度最高。1日平均入院患者数300.7人も今年度最高で、予算とほぼ同水準。ただし累計では284.4人で予算293.8人を下回る（資料1-1、資料1）。前年度対比では、累計の病床稼働率は89.7%→88.9%（△0.8pt）と前年をわずかに下回っているものの目標92.0%に対する乖離は縮小傾向にある。新入院患者数は9,359人→9,595人（+236人、+2.5%）と前年を上回っている（資料1-1）。

5.2 入院単価・在院日数

指標	2月実績	予算/目標	前年同月	累計平均	前年累計	累計前年比	出典
入院単価	97,424円	98,511円	98,105円	101,517円	97,592円	+3,925円（+4.0%）	資料1-1
平均在院日数	9.1日	9.0日	9.5日	8.9日	—	△0.4日（△4.2%）	資料1-1

【事実】
2月の入院単価は97,424円で予算を若干下回り、前年同月の98,105円からも△681円。ただし累計では101,517円と前年（97,592円）から+3,925円（+4.0%）の大幅増加に成功している（資料1-1）。平均在院日数は9.1日で前年9.5日から0.4日短縮（△4.2%）。

【解釈】
在院日数短縮は効率性の改善を示すが、入院単価の低下を招きうるため、高度医療の集約によるケースミックスの改善が重要。累計の入院単価+4.0%は、在院日数短縮にもかかわらず単価を引き上げていることを意味し、1入院あたりの診療密度が向上していると評価できる。

5.3 手術件数

指標	2月実績	前年同月	前年比	3月実績	前年3月	前年比	年度合計（4〜3月）	前年年度合計	前年比	出典
手術室件数合計	497件	484件	+13件	479件	518件	△39件	6,336件	6,162件	+174件（+2.8%）	資料1、資料3
全麻件数	265件	241件	+24件	249件	269件	△20件	3,261件	3,186件	+75件（+2.4%）	資料3
局麻件数	232件	243件	△11件	230件	249件	△19件	3,075件	2,976件	+99件（+3.3%）	資料3
緊急手術件数	36件	38件	▲2件	—	—	—	582件以上	—	—	資料3

【事実】
3月データの追加により2025年度が完結した。年度合計6,336件は前年6,162件に対し+174件（+2.8%）の増加（資料3）。全身麻酔は年度合計3,

261件で、急性期充実体制加算の施設基準（全麻2,000件/年以上）を大幅に超過（163%）。緊急手術も4～2月累計で既に582件であり、施設基準（350件/年以上）を余裕で達成している。全麻率は51.5%（前年51.7%）と安定。

3月単月では479件（前年518件、△39件）と前年を下回ったが、これは月次変動の範囲内であり、年度を通じた増加基調を損なうものではない。

診療科別年度合計（資料3）：

診療科	年度合計	前年年度合計	前年比	増減率	注目点
眼科	2,502件	2,468件	+34件	+1.4%	最大件数、安定推移
外科	976件	945件	+31件	+3.3%	堅調な増加
整形外科	767件	774件	△7件	△0.9%	微減、要モニタリング
泌尿器科	429件	417件	+12件	+2.9%	ダヴィンチ手術が寄与
形成外科	401件	382件	+19件	+5.0%	堅調
耳鼻科	392件	369件	+23件	+6.2%	好調
産婦人科	319件	256件	+63件	+24.6%	年度最大の成長
心外科	258件	271件	△13件	△4.8%	減少、要注意
脳外科	154件	153件	+1件	+0.7%	横ばい
循環器内科	105件	95件	+10件	+10.5%	好調
皮膚科	19件	23件	△4件	△17.4%	少数だが減少
腎臓内科	10件	6件	+4件	+66.7%	新規拡大
麻酔科	4件	2件	+2件	+100%	少数

【解釈】
産婦人科が+63件（+24.6%）と年度最大の成長を記録しており、診療体制の充実が寄与していると考えられる。一方、整形外科（△7件）と心外科（△13件）は減少しており、来年度に向けた対策が必要である。外科（+31件）、耳鼻科（+23件）、形成外科（+19件）も着実に増加しており、多くの診療科で手術件数の拡大が実現している。

5.4 特定入院料

病棟	2月算定率	目標	累計平均	評価	出典
ICU	84.5%	80.0%	79.7%	○達成	資料1-1、資料4
HCU	85.4%	80.0%	73.5%	○達成	資料1-1、資料4
SCU	91.1%	90.0%	95.5%	○達成	資料1-1、資料4

【事実】
2月は3病棟とも目標を達成。特にHCUは85.4%で今年度最高値を記録。ICUの金額は2月17,558千円で前年比+2,075千円（資料4）。SCUは累計で人数346人（前年273人比+73人）と大幅増加（資料4）。

【解釈】
特定入院料の算定改善は入院収入を下支えしている。ICUの稼働率は2月84.5%と前月の95.2%から低下しており、稼働の波の平準化が課題。

---

6. 外来部門分析

6.1 患者数

指標	2月実績	予算	予算差	前年同月	前年比	出典
1日平均外来患者数	846.4人	944.4人	△98.0人（△10.4%）	929.6人	△83.2人（△9.0%）	資料1
延患者数	19,467人	-	—	19,521人	△54人	資料1-1
1日平均初診患者数	61.5人	-	—	68.6人	△7.1人（△10.3%）	資料1-1
初診率	7.3%	10.0%（目標）	未達	7.4%	△0.1pt	資料1-1、資料10

【事実】
外来患者数は予算比△98.0人（△10.4%）、前年比△83.2人（△9.0%）と大幅な未達。初診患者数も前年比△7.1人（△10.3%）（資料1）。累計の初診患者数16,688人は目標26,481人の63%にとどまる（資料10）。前年度対比でも患者数の減少が続いており、外来部門の最大の課題である。

6.2 外来単価

指標	2月実績	予算	予算差	前年同月	前年比（2月）	累計平均	前年累計	累計前年比	出典
外来単価	24,001円	22,647円	+1,354円	22,206円	+1,795円（+8.1%）	22,841円	21,551円	+1,290円（+6.0%）	資料1-1

【事実】
外来単価は24,001円で今年度最高を更新（前月23,784円）。予算比+1,354円、前年比+1,795円（+8.1%）と好調。累計でも22,841円で前年21,551円から+1,290円（+6.0%）の大幅上昇を実現している（資料1-1）。

【解釈】
単価向上は外来化学療法の増加や高度医療の推進の成果と推測される。前年度対比+6.0%の単価上昇は、患者1人あたりの診療内容の高度化を示しており、外来部門の質的向上は着実に進んでいる。ただし患者数減を補うには至っておらず、量的回復との両立が不可欠である。

6.3 紹介率・逆紹介率

指標	2月実績	基準	前年同月	前年比	出典
紹介率	87.1%	65%以上	83.8%	+3.3pt	資料7
逆紹介率	99.1%	40%以上	104.5%	▲5.4pt	資料7
紹介割合（診療報酬算定要件）	99.8%	50%以上	-	-	資料7
逆紹介割合	80.0パーミル	30パーミル以上	-	-	資料7

【事実】
紹介率87.1%、逆紹介率99.1%で基準を十分に充足。ただし紹介件数は2月1,105件で累計12,652件、前年同期累計12,936件から▲284件（▲2.2%）の減少（資料1-1）。なお前年度通年では15,022件（資料10）。

7. 各部門分析

7.1 外来化学療法

指標	2月実績	前年同月	前年比	出典
算定件数	252件	209件	+43件（+20.6%）	資料2
算定金額	1,875千円	1,489千円	+386千円（+25.9%）	資料2
予約患者数	293人	237人	+56人	資料2
算定実患者数	181人	159人	+22人	資料2
1日平均予約患者数	12.7人	11.3人	+1.4人	資料2

【事実】
外来化学療法は大幅に増加。累計2,939件（前年2,514件、+425件）で全月前年超え。外科が牽引（累計1,481件、前年1,338件、+143件）。消化器内科・泌尿器科も増加（資料2）。

【解釈】 外来化学療法の拡大は外来単価向上の主要因の一つ。引き続き拡大を推進すべき好材料。

7.2 手術部門（詳細）

2月の診療科別手術件数上位（資料3）：

診療科	2月件数	前年比	特記
眼科	204件	▲2件	局麻中心、安定推移
外科	84件	+12件	全麻率100%、好調
整形外科	46件	▲7件	減少傾向、要注意
泌尿器科	39件	+7件	増加基調
耳鼻科	33件	+2件	安定

3月実績（資料3）：

3月は手術総計479件（前年518件、△39件）。全身麻酔249件（前年269件、△20件）、局所麻酔230件（前年249件、△19件）と、全麻・局麻ともに前年を下回った。

年度合計の施設基準充足状況（資料3）：

基準項目	施設基準	年度合計実績	充足率	評価
全身麻酔件数	2,000件/年以上	3,261件	163%	○大幅超過
緊急手術件数	350件/年以上	582件以上	166%以上	○大幅超過

急性期充実体制加算の施設基準はいずれも大幅に超過しており、安定的に充足している。

ダヴィンチ手術: 2月11件、累計112件（月平均10.2件）で目標（月平均10件）達成（資料10）。

7.3 リハビリテーション

指標	2月実績	前年同月	前年比	出典
算定単位数	2,440単位	1,958単位	+482単位	資料5
算定金額	5,385千円	4,307千円	+1,078千円	資料5
1日平均単位数	106.1単位	93.2単位	+12.9単位	資料5
リハ総合計画評価料	104件	108件	▲4件	資料5

【事実】
リハビリは2月に大きく回復。累計では前年比▲1,267単位だったが、直近3ヶ月（12月～2月）は前年超えが続く。脳血管リハ995単位（+118）、廃用リハ276単位（+246）が増加（資料5）。

【解釈】
廃用症候群リハの増加は入院患者のADL維持向上への取り組みの成果。一方、運動器リハは797単位（前年684単位、+113）だが累計ベースでは前年比▲832単位と低迷。

7.4 早期離床・リハビリテーション加算

指標	2月実績	前年同月	累計	出典
件数	61件	40件	493件	資料5
金額	305千円	200千円	2,465千円	資料5
算定率	43.0%	31.5%	30.9%（平均）	資料5

【事実】 2月の算定率43.0%は今年度最高。前年の31.5%から大幅改善。

7.5 後発医薬品

指標	2月実績	目標	累計	出典
後発医薬品指数（数量ベース）	96.1%	90%以上	95.9%	資料6
カットオフ値割合	55.3%	50%以上	54.0%	資料6
金額ベース（入院）	88.3%	80%以上	94.1%	資料6
金額ベース（全体）	52.2%	-	57.2%	資料6

【事実】
後発医薬品使用体制加算1（47点）の算定要件（90%以上）を安定的に充足。金額ベース入院は2月88.3%で累計平均94.1%からやや低下したが目標80%は達成（資料6、資料10）。

【解釈】 先発医薬品使用上位にはフォシーガ錠10mg（0.5%）、テルネリン錠1mg（0.3%）等があり、後発品への切替余地がある（資料6）。

7.6 退院支援

指標	2月実績	前年同月	前年比	出典

入退院支援加算件数	291件	259件	+32件	資料8
退院患者割合	35.0%	32.5%	+2.5pt	資料8
入院時支援加算	102件	112件	▲10件	資料8
加算含む金額	2,290千円	2,093千円	+197千円	資料8

【事実】
入退院支援加算は累計3,116件で前年比+147件。2月は291件で好調。入院時支援加算は102件で前年同月112件をやや下回るが、累計1,047件は前年1,043件とほぼ同水準（資料8）。

退院支援関連では退院時共同指導料2が2月10件（前年7件、+3件）と増加。介護支援連携指導料は累計67件で施設基準（48件/12ヶ月）を充足（過去12ヶ月74件、資料8）。

7.7 放射線治療

指標	2月実績	前年同月	前年比	出典
放射線治療管理料	25件	11件	+14件	資料9
体外照射	251件	238件	+13件	資料9
IMRT	236件	77件	+159件	資料9
算定金額	16,326千円	9,464千円	+6,862千円	資料9

【事実】
2月は放射線治療が大幅に回復。IMRT236件は今年度最高で、前年同月77件の3倍超。累計算定金額121,884千円は前年144,784千円に対し▲22,900千円だったが、直近での巻き返しが顕著（資料9）。

がん種別では乳がんが最多（累計147件、前年196件）。肺がんは累計72件で前年55件を上回る。精巣がん23件は新規算定（資料9）。

7.8 病診連携

指標	2月実績	前年同月	前年比	出典
紹介件数	1,105件	1,046件	+59件	資料7
逆紹介件数	1,258件	1,304件	▲46件	資料7
救急車受入件数	257件	-	-	資料10
救急車謝絶率	21.8%	30%目標	○達成	資料10

紹介元減少が著しい医療機関（3件以上減少、資料7-2）：
明大前クリニック（▲10件）、島津メディカルクリニック（▲5件）、こうらクリニック（▲5件）等、計27医療機関で3件以上の減少。

診療科別紹介件数の変化（前年度対比、資料7-2）：
- 増加: 心外科+150%、放射科+127.3%、乳癌セ+88.9%、小児科+65.0%、腎臓内+52.4%
- 減少: 精神科▲100%、麻酔科▲83.3%、耳鼻科▲20.2%、呼吸内▲13.2%、消化内▲13.7%

紹介受入拒否（資料7-1）：
2月は11件の拒否。うちベッド満床が7件（呼吸器2、消化器1、整形3、皮膚1）、処置困難が3件（外科1、婦人科1、整形1）、対応困難1件。

7.9 土曜日実績（令和8年3月分）

3月の土曜日実績データが新たに入手された（資料1-3）。土曜診療は外来患者の受診利便性確保と収益機会の拡大において重要な位置づけにある。

手術実績（資料1-3）

項目	月間合計	週平均	出典
手術件数	12件	3.0件	資料1-3
全身麻酔	8件	2.0件	資料1-3
局所麻酔	4件	1.0件	資料1-3

【事実】
3月の土曜日手術は月間12件で、全身麻酔8件（66.7%）、局所麻酔4件。週別では第1週・第4週が各4件と高水準であったが、第3週（3/21）は1件のみに低下した。全身麻酔比率66.7%は平日の全麻率51.5%を上回っており、土曜日には比較的侵襲度の高い手術が集約されている傾向がある。

入院・外来実績（資料1-3）

項目	月間合計	週平均	最多週	最少週	出典
入院患者数	44人	11.0人	第3週13人（118%）	—	資料1-3
外来患者数	1,619人	404.75人	第2週492人（122%）	第3週323人（80%）	資料1-3
初診患者数	159人	39.75人	—	—	資料1-3
初診割合	9.8%	—	—	—	資料1-3

【事実】
外来患者数は月間1,619人（週平均404.75人）で、週ごとの変動が大きい。第2週（3/14）が492人と最多（対平均122%）で全体的に高水準であった一方、第3週（3/21）は323人（対平均80%）と最少であった。第3週の低調は春分の日（3/20）翌日であることが影響していると考えられる。

初診患者数は月間159人（初診割合9.8%）で、平日の初診率7.3%（2月実績）を上回っている。土曜日は平日に受診が困難な勤労世代の初診需要を捉えている可能性がある。

入院患者数は月間44人（週平均11人）で、外来患者数が最少であった第3週に入院が最多（13人、対平均118%）となっている点は特徴的であり、祝日前後の予定入院の調整が反映されていると考えられる。

【解釈】　土曜日の初診割合9.8%は平日を上回り、新患獲得チャネルとして重要な役割を果たしている。外来患者数の週次変動（第2週492人　vs 第3週323人）は祝日影響が主因であるが、安定的な患者確保のための広報施策や予約調整の工夫が求められる。また、土曜手術の全麻比率が高いことから、手術室運用の効率化（平日への分散可能性）も検討に値する。

---

8. 年度末見通し

8.1 収入見通し

項目	4～2月累計	年度予算（推計）	進捗率	達成可能性	出典
診療費総額	14,818,646千円	約16,450,000千円	90.1%	極めて困難	資料1-1
入院	9,644,523千円	約10,590,000千円	91.1%	困難	資料1-1
外来	5,174,123千円	約5,970,000千円	86.7%	不可能	資料1-1

【解釈】
累計の予算未達▲322,390千円を3月に取り戻すことは不可能。年度着地としては予算比97～98%（未達額3～4億円程度）と見込まれる。特に外来は累計予算対比94.6%で、構造的な患者数減少への対策が来年度の最重要課題となる。

8.2 主要目標の達成状況

目標項目	目標値	実績	評価	出典
病床稼働率	92.0%	88.9%	未達	資料10
平均在院日数	9.0日	8.9日	○達成	資料10
DPC期間II以内退院率	70.0%	71.9%	○達成	資料10
クリニカルパス使用率	60.0%	65.1%	○達成	資料10
外来初診率	10.0%	7.4%	未達	資料10
救急車謝絶率	30.0%以下	20.2%	○達成	資料10
紹介患者数	月1,300件	月1,150件	未達	資料10
後発医薬品割合（入院金額）	80.0%	94.1%	○達成	資料10
ダヴィンチ手術	月10件	月10.2件	○達成	資料10
査定率	0.40%	0.54%	未達	資料10
手術件数（年度合計）	—	6,336件（前年比+2.8%）	○前年超	資料3
全身麻酔件数（年度合計）	2,000件/年以上	3,261件	○大幅超過（163%）	資料3
緊急手術件数	350件/年以上	582件以上	○大幅超過（166%以上）	資料3

【事実】
手術関連の施設基準はすべて大幅に超過して達成している。全身麻酔3,261件は基準2,000件の163%、緊急手術582件以上は基準350件の166%以上であり、急性期充実体制加算の維持に全く懸念がない水準である（資料3）。年度合計の手術件数6,336件は前年6,162件を+174件上回り、手術部門は量的にも成長を実現した。

8.3 前年度対比の総括

年度を通じた前年度対比を総括すると、予算未達という評価の裏側に、実績ベースでの着実な経営改善が確認できる（資料1、資料1-1）。

成長が確認される指標

指標	前年度実績	当年度実績	増減	増減率	出典
医療収入（累計）	15,062,283千円	15,527,317千円	+465,034千円	+3.1%	資料1
収入合計（累計）	15,290,465千円	15,841,950千円	+551,485千円	+3.6%	資料1
粗利益（累計）	55,297千円	122,991千円	+67,694千円	+122.4%	資料1
入院単価（累計）	97,592円	101,517円	+3,925円	+4.0%	資料1-1
外来単価（累計）	21,551円	22,841円	+1,290円	+6.0%	資料1-1
手術件数（年度合計）	6,162件	6,336件	+174件	+2.8%	資料3

病床稼働率（累計）	89.7%	88.9%	△0.8pt	—	資料1-1
新入院患者数（累計）	9,359人	9,595人	+236人	+2.5%	資料1-1
平均在院日数	9.5日	9.1日	△0.4日	△4.2%	資料1-1

課題が残る指標

指標	前年度実績	当年度実績	増減	増減率	出典
1日平均外来患者数	929.6人	846.4人	△83.2人	△9.0%	資料1
人件費（2月単月）	409,471千円	440,637千円	+31,166千円	+7.6%	資料1
医療経費（累計）	5,958,888千円	6,313,137千円	+354,249千円	+5.9%	資料1
粗利益率（累計）	0.4%	0.8%	+0.4pt	—	資料1

【総括】

収益力の向上:
医療収入は累計+3.1%（+4.7億円）の成長を達成。入院収入+3.3%、外来収入+2.4%とバランスよく成長している。特に入院単価+4.0%、外来単価+6.0%の上昇は、診療の質的向上と効率化の成果である。

利益構造の改善:
粗利益は前年の2倍以上に改善（55,297千円→122,991千円、+122.4%）。収入成長率（+3.6%）が支出増加率（+3.2%）を上回る構造が構築された。ただし粗利益率0.8%は依然として極めて薄く、さらなる改善が必要である。

3病院中で最も健全な改善:
前年度対比では、大森（粗利益△32.9%）・佐倉（粗利益△26.4%）が減益する中、大橋のみが増益。累計の人件費増加率も+0.3%で3病院中最小。予算対比と前年度対比で評価が逆転する点は、予算設定の見直しを含めた多面的な経営評価の必要性を示している。

残された課題:
外来患者数の減少（前年比△9.0%）は依然として最大の経営課題であり、患者数回復なくして持続的な成長は困難である。また、2月単月の人件費+7.6%が一時的な変動か構造的な増加かの見極めが重要である。医療経費の累計+5.9%増も、収入成長率を上回る水準であり、コスト管理の強化が求められる。

来年度への示唆:
前年度対比の実績を踏まえれば、大橋病院は正しい方向に進んでいる。予算策定にあたっては、実績ベースの成長率（収入+3〜4%）を基盤としつつ、外来患者数回復による上積み余地を織り込んだ現実的な目標設定が望ましい。

---

9. 経営課題と提言

優先度A（緊急・重要：直ちに対応すべき課題）

A-1. 外来患者数の回復【最優先】

・現状: 1日平均846.4人（予算比▲10.4%、前年比▲9.0%）。初診患者数も▲10.3%減
・具体策:
紹介件数減少が著しい27医療機関（資料7-2）への個別訪問・関係修復
整形外科（累計▲543件）、耳鼻科（累計▲182件）、消化器内科（累計▲283件）の紹介減少原因の特定と対策
外来単価1,500円以下の患者割合21.4%（目標20%以下）の改善 → 逆紹介の推進で低単価患者を地域に戻す
医師による医療機関訪問（月10.5件）の増加、特に紹介減少診療科の医師参加促進

・効果見込み: 外来患者数を1日50人増加させれば、月間約2,700万円の増収（外来単価24,001円で概算）

A-2. 人件費の適正管理

・現状: 前年比+7.6%（2月単月）、累計予算比+105,674千円（+1.6%）
・具体策:
診療科別・部門別の人件費分析と増加要因の特定
超過勤務の削減目標設定（タスクシフト・タスクシェアの推進）
変動費としての非常勤・派遣比率の適正化
・効果見込み: 人件費増加率を+2%以内に抑制すれば、年間約2億円の費用削減

優先度B（重要：今年度内に方向性を定める課題）

B-1. 入院単価の安定化

・現状: 2月97,424円と累計平均101,517円から低下
・具体策:
救急医療管理加算1の算定構成比を維持・向上（2月69.8%と改善傾向、資料1-1）
特定入院料の算定率を安定化（ICU月次変動が大きい：67.2%～92.5%）
薬剤管理指導料の算定件数回復（2月1,757件で横ばい、累計前年比▲697件、資料1-1）

B-2. 整形外科の立て直し

・現状: 手術件数46件/月（前年53件から▲7件）、紹介件数も累計▲543件。年度合計767件（前年774件、△7件）
・具体策:
手術枠の見直し・効率化
紹介受入拒否の削減（2月にベッド満床で整形3件拒否、資料7-1）
地域整形外科クリニックとの連携強化

B-3. 査定率の改善

・現状: 累計0.54%（目標0.40%）。査定額累計74,349千円（資料10）
・具体策:
診療科別ヒアリングの継続と指摘事項のフィードバック強化
高額査定案件の重点レビュー
レセプトチェック体制の強化

優先度C（中期的課題：来年度計画に反映すべき事項）

C-1. 外来化学療法のさらなる拡大

・現状: 累計2,939件（前年比+425件）で好調だが成長余地あり
・具体策: 水曜・木曜に集中する予約の分散化、化学療法室のキャパシティ拡大検討

C-2. リハビリテーション体制の強化

・現状: 累計単位数は前年比▲1,267だが、直近3ヶ月は回復基調
・具体策: 運動器リハの回復促進、セラピスト確保、早期離床加算の算定率向上（現在30.9%→目標40%）

C-3. 放射線治療の安定的な患者確保

・現状: 月次変動が大きい（金額6,823千円～16,326千円）
・具体策: 乳がん以外のがん種（肺がん・泌尿器系）の放射線治療症例の安定確保

C-4. マイナ保険証利用促進の継続

・現状: 直近65.3%（目標45%達成済み、資料10）
・具体策: 高い利用率を維持し、医療DXの基盤整備に活用

付録：データ出典一覧

資料番号	資料名	主な利用データ
資料1-1	医事統計	入院・外来の患者数、稼働率、単価、診療費、特定入院料算定率
資料1-2	診療科別前年（月平均）比較	診療科別の外来・入院収入、患者数、単価の前年度月平均との比較
資料1	3病院収支比較表	収入・支出・粗利益の3病院比較、診療実績
資料1-3	土曜日実績（令和8年3月分）	土曜日の手術・入院・外来・初診の週別実績
資料2	外来化学療法加算算定状況	化学療法件数・金額・診療科別実績
資料3	手術資料（年度完結版）	診療科別手術件数、全麻・緊急手術件数、年度合計
資料4	特定入院料算定状況	ICU・HCU・SCUの算定件数・稼働率・算定率
資料5	リハビリテーション算定状況	リハビリ種別算定単位数・金額
資料6	後発医薬品指数推移	後発品使用率（数量・金額ベース）
資料7	紹介率・逆紹介率推移	紹介・逆紹介件数、診療科別実績
資料7-1/7-2	病診連携室提出資料	紹介受入状況、拒否件数、紹介元別増減
資料8	退院支援関連項目算定状況	入退院支援加算・介護支援連携指導料等
資料9	放射線治療算定状況	放射線治療件数・金額・がん種別実績
資料10	3病院指摘検討事項	各種目標値と進捗状況

本レポートは上記資料のデータに基づき作成しています。「【事実】」はデータから直接読み取れる内容、「【解釈】」は分析者による推測・考察です。